

URGENCIAS MÉDICAS EN LA CLÍNICA DENTAL

Clínica Universitaria de Odontología

Lo más importante ante una urgencia médica que surja en la clínica dental, es saber reconocerla para poder actuar a tiempo y de forma correcta.

Siempre que ante una urgencia médica requerimos la intervención de los servicios médicos de emergencia, lo haremos a través del número de teléfono 112, desde donde se transferirá la llamada al CCU (Centro Coordinador de Urgencias) de SAMU-Asturias, quienes movilizarán los recursos necesarios.

Las situaciones de urgencia médica más importantes que nos podemos encontrar en la clínica dental son:

- Parada cardíaca.
- Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
- Reacción alérgica.
- Síncope.
- Dolor torácico.
- Disnea.
- Convulsiones.
- Hipoglucemia.
- Crisis de ansiedad.

PARADA CARDÍACA

Ante una pérdida de conciencia, en la que se comprueba que el paciente no responde y no respira, sospecharemos una parada cardíaca, estando indicado iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar según el siguiente algoritmo:

Algoritmo de soporte vital básico en adultos

Soporte Vital Básico



OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO

Ante un atragantamiento en que el paciente es capaz de toser, sospecharemos obstrucción moderada. Cuando ya no es capaz de toser, nos encontraremos ante una obstrucción severa.

En cada uno de los casos, actuaremos según el siguiente algoritmo:



REACCIÓN ALÉRGICA

Sospechar ante la presencia de los siguientes signos/síntomas, de forma aislada o en conjunción, tras la exposición a una sustancia extraña:

- Obstrucción de la vía aérea (edema de glotis, dificultad respiratoria).
- Síntomas digestivos.
- Reacción cutánea extensa (urticarial).
- Hipotensión e incluso pérdida de conciencia.

Actitud a seguir:

1. Avisar al 112
2. Control de signos vitales
3. Si hipotensión: tumbar al paciente con las piernas elevadas (posición de Trendelenburg).
4. Garantizar apertura de la vía aérea y si se dispone de oxígeno, se administrará a flujos elevados.
5. Si disminución del nivel de conciencia: colocar al paciente en posición lateral de seguridad y mantener la apertura de la vía aérea.
6. Si clínica severa: administrar adrenalina por vía intramuscular, preferiblemente en vasto externo de cuádriceps (región externa de muslo), a una dosis de 0,5 mg, repetida a los 5 minutos si no hay mejoría.
7. Ante parada cardíaca: iniciar maniobras de RCP básica.

SÍNCOPE

Pérdida de conciencia transitoria con recuperación completa. Puede acompañarse de hipotensión, sudoración, palidez, relajación de esfínteres, sensación previa de mareo.

Actitud a seguir:

1. Tumbar al paciente con las piernas elevadas (posición de Trendelemburg).
2. Aflojar las ropas.
3. Tranquilizar al paciente.
4. Vigilar signos vitales (respiración, pulso, tensión arterial...).
5. Si no recupera, avisar a 112.

DOLOR TORÁCICO

Ante dolor precordial intenso, generalmente opresivo, que puede irradiar a miembro superior izquierdo, cuello, mandíbula o espalda, y que puede acompañarse de cortejo vegetativo (sudoración, mareo, náuseas), cabe sospechar origen coronario del mismo.

Actitud a seguir:

1. Avisar al 112.
2. Es fundamental tranquilizar al paciente en espera del traslado.
3. Colocarlo sentado o semiincorporado, con las ropas flojas, evitando que tenga frío.
4. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y lleva consigo Cafinitrina®, se le puede dar un comprimido sublingual, y repetir a los 5 min si no hay mejoría clínica.
5. En caso de parada cardíaca: iniciar maniobras de RCP básica.

DISNEA

Ante paciente que presenta dificultad para respirar, acompañada de “pitos” o sibilancias y tos persistente, taquicardia y/o taquipnea, cabe sospechar una CRISIS ASMÁTICA.

Actitud a seguir:

1. Avisar al 112.
2. Colocar al paciente sentado y tranquilizarle.
3. Administrar 2-4 puff de salbutamol o del broncodilatador que el paciente lleve consigo (en la dosis habitual) y repetir cada 20 minutos si no mejora.
4. Monitorización de la saturación de O₂ con el pulsioxímetro si es posible.
5. Comenzar con oxigenoterapia a alto flujo (mediante mascarilla Venturi) si se dispone de ella (objetivo: saturación de O₂ por encima de 90%).

CONVULSIONES

Se caracterizan por la pérdida de conciencia acompañada de movimientos tónicos y/o clónicos, de inicio brusco, con cianosis; puede haber sialorrea, mordedura de lengua y relajación de esfínteres. Al cesar la convulsión, el paciente puede quedar en estado postcrítico (confusión, desorientación, somnolencia, cefalea).

Actitud a seguir:

1. No intentar frenar los movimientos.
2. Evitar que se lesione: Retirar objetos (punzantes, gafas, etc.), aflojar ropa.
3. No introducir objetos en la boca.
4. Avisar al 112.
5. Una vez han cesado las convulsiones, si está inconsciente: colocar en posición lateral de seguridad y vigilar signos vitales.

HIPOGLUCEMIA

Ante cifras de glucemia por debajo de 50 mg/dL pueden presentarse: sensación de hambre, debilidad, cansancio, temblor, confusión, nerviosismo/ansiedad, palidez, sudoración, visión borrosa, mareo, cefalea. Puede llegar a perder la conciencia.

Actitud a seguir:

1. Mantener al paciente sentado.
2. Aportar hidratos de carbono: 15 g de glucosa oral (3 cucharaditas de azúcar o 100 ml de refresco). Repetir a los 15 min hasta cifras de glucosa por encima de 70 mg/dL.
3. Si pierde la conciencia: colocar en posición lateral de seguridad y avisar al 112.
4. Si se dispone de cifra de glucemia (glucómetro), constatando la hipoglucemia grave (generalmente en diabéticos a tratamiento con insulina), administrar 1 mg de glucagón im (muslo, nalga o brazo); (kit conservado en nevera).

CRISIS DE ANSIEDAD

Ante ansiedad acompañada de agitación, taquicardia, hiperventilación, palpitaciones, e incluso mareo:

Actitud a seguir:

1. Tranquilizar al paciente.
2. Mantenerle sentado.
3. Hacerle respirar en una bolsa.
4. Continuar tranquilizándole.
5. En caso de no presentar contraindicaciones, se le puede administrar una benzodiacepina sublingual (por ej.: alprazolam 0,25-0,5 mg).
6. Si no mejora, avisar al 112.